

CASO CLÍNICO 9

Entendiendo al usuario

GRUPO 14



CASOS DE REFERENCIA

DATOS	CASO 1	CASO 2	CASO 3
EDAD / SEXO	25 AÑOS / MASCULINO	51 AÑOS / MASCULINO	25 AÑOS / MASCULINO
TIPO DE LESION	CERVICAL TRAUMATICA	CERVICAL INCOMPLETA	T10 - AIS A
CONSECUENCIA	TETRAPLEJICA	ALTERACIONES MOTORAS Y FUNCIONALES	PARAPLEJIA COMPLETA
PROBELMAS PRINCIPALES	DEPENDENCIA DE AVD	DISFAGIA, PROBLEMAS ESFINTERIANOS Y MOVILIDAD	LESION POR PRESION
INTERVENCION	REHABILITACION INTEGRAL	REHABILITACION INTERDISCIPLINARIA	MEMBRANA DE FIBRINA RICA EN PLAQUETAS
RESULTADO	MAYOR DEPENDENCIAL FUNCIONAL	MEJORA DE MOVILIDAD Y AVD	CICATRIZACION COMPLETA
PUNTO CLAVE	REHABILITACION → INDEPENDENCIA	TIPO DE LESION → FUNCIONALIDAD	COMPLICACIONES → SOLUCIONES BIROMEDICAS

PERFIL FUNCIONAL

01

CAPACIDADES CONSERVADAS

- Orientación, conciencia y comunicación
- Movilidad pasiva mayormente conservada



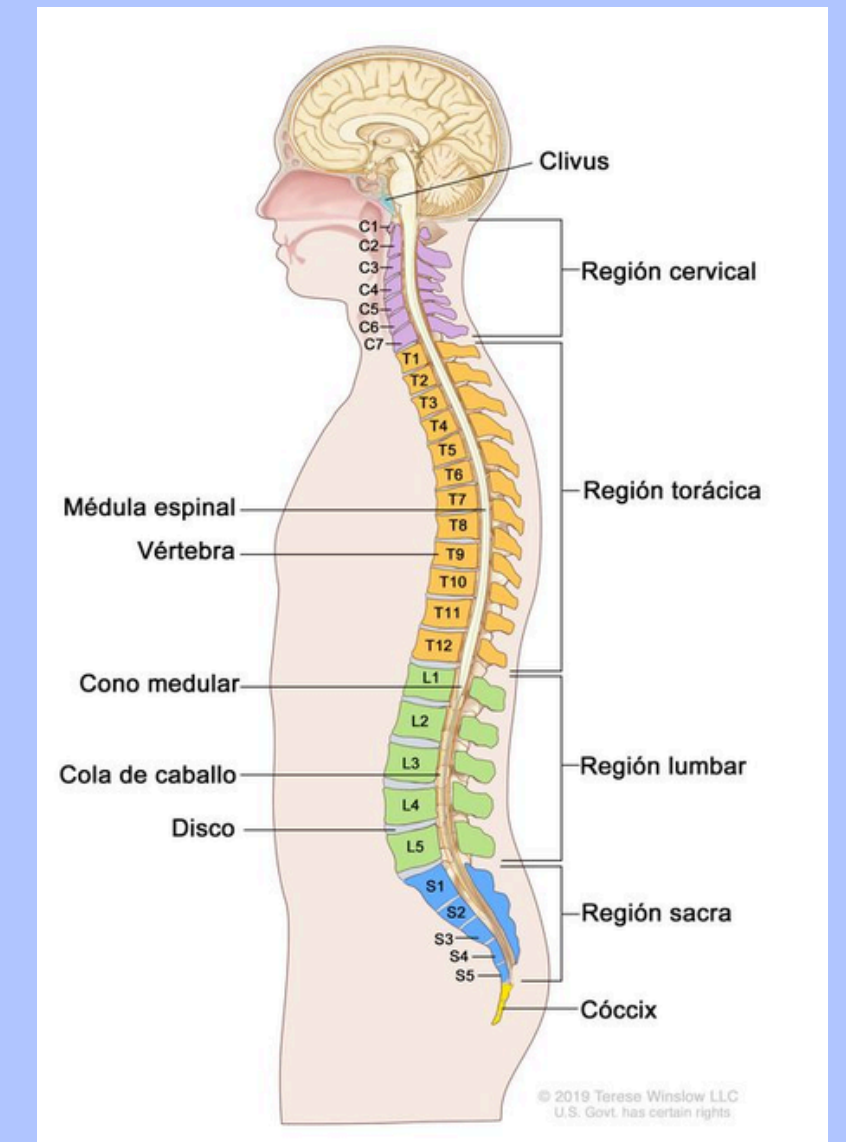
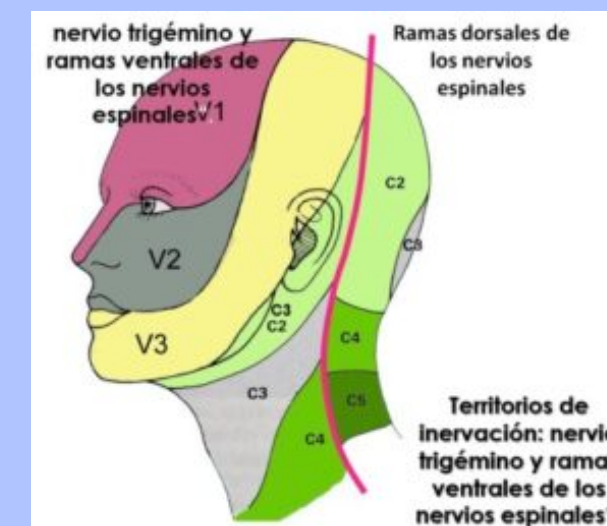
DEPENDENCIA ELEVADA

- Alimentación
- Higiene
- Transferencias
- Movilidad
- Posicionamiento y alivio de presión

02

LIMITACIONES

- Movilidad activa miembros superiores: muy disminuida
- Movilidad activa miembros inferiores: ausente
- Fuerza: C5 → 3/3 | C6-S1 → 0/0
- Control de tronco
- Sensibilidad ausente desde C5-S5
- Lesión por presión sacra



MAPA DE ACTIVIDADES CRÍTICAS

VIDA DIARIA

- Requiere asistencia para cada actividad debido a su tetraplejía, siendo dependiente de al menos una persona en todo momento;
- Al momento de colocarla en la camilla se hace uso de una grúa para pacientes.

REHABILITACIÓN:

- Acude a terapia psicológica, sin embargo permanece pesimista sobre su situación y su mejoría.
- A pesar de las terapias es muy dependiente de ayuda externa. (No colabora mucho)

LABORALES/EDUCATIVAS

- Es económicamente dependiente.
- Su participación social es disminuida y está limitada, reforzado al estar internada.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE PREVENCIÓN/PROGRESIÓN

- Para evitar lesiones por presión mantiene su terapia física, además de prevenir el empeoramiento de su herida en la región sacra.

BARRERAS Y FACILITADORES

Barreras (Factores Limitantes)

Económico / Social: Dependencia económica total y ausencia del cuidador principal por trabajo.

Físico / Estructural: Uso de silla mecánica sin autonomía para desplazarse (depende de terceros).

Salud Secundaria: Úlcera sacra severa (Grado III-IV) que limita el tiempo sentada y retrasa la rehabilitación.



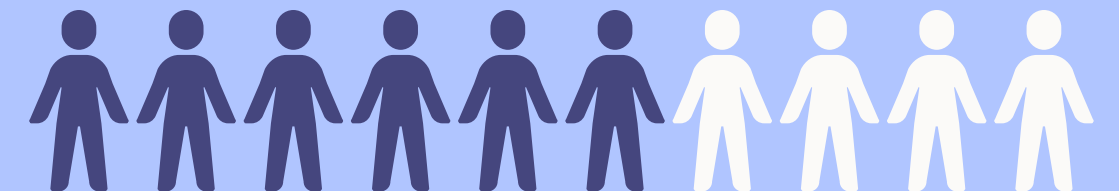
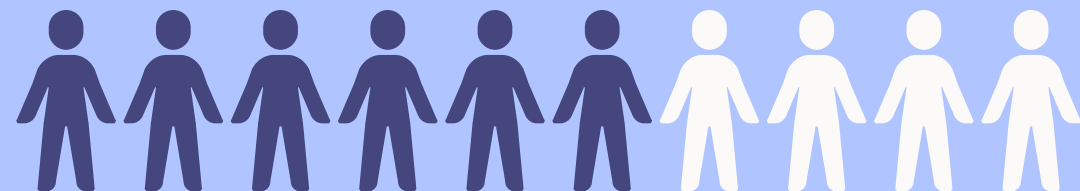
BARRERAS Y FACILITADORES

Facilitadores (Factores de Apoyo)

Social / Institucional: Respaldo médico, psicosocial y seguimiento continuo por parte del INR.

Cognición y Comunicación: Estado lúcido y lenguaje intacto que le permite dirigir su propio cuidado.

Fisiológico: Respiración espontánea y deglución conservada (no depende de soporte vital).



MAPA DE DOLOR (PAIN POINTS)

Traslado

Alimentacion e Higiene

Rehabilitacion

Descripcion

Al trasladarse de la cama a la silla de ruedas necesita una grua y para el traslado externo depende de la silla de ruedas

Las actividades de vida diaria como alimentarse, vestirse o bañarse quedan fuera de su alcance

Realiza una rehabilitacion integral en el INR en donde se encuentra actualmente hospitalizada

¿Que tipo de ayuda requiere?

Usualmente necesita de 1 a 2 personas para el traslado con la grua

Depende totalmente del personal del hospital para sus AVD

Ejercios de rehabilitacion especificos para pacientes con LME a cargo de terapeutas, no realiza los ejercicios por si sola

¿Presenta molestias?

Tiene lesiones por presion en la region sacra

Necesita de sonda Foley

Presento dificultades para realizar las terapias debido a su estado psicologico

EXPECTATIVAS DEL USUARIO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod id sem quis accumsan. Sed tempus placerat velit a placerat. Cras suscipit est at mauris blandit efficitur finibus non augue. Cras suscipit est at mauris blandit efficitur finibus non augue.

